

Tromboembolismo pulmonar - abordagem

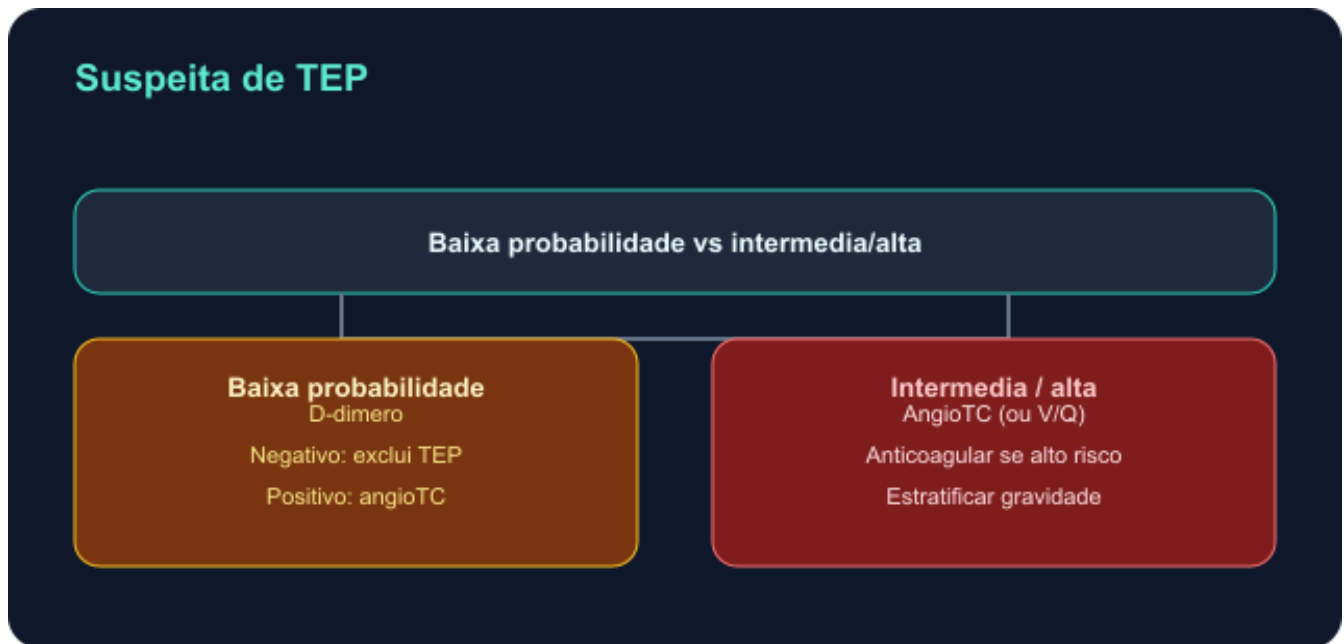
TEP exige estratificar probabilidade pré-teste (Wells/Geneva), usar D-dímero para exclusão em baixa probabilidade e angioTC quando a suspeita for intermediária/alta.

Sinais de gravidade

Lembre - Sinais de gravidade

Hipotensão/choque = TEP de alto risco !' suporte + anticoagulação e considerar trombólise sistêmica.
Disfunção de VD / troponina! / BNP! = risco intermediário — monitorar de perto.

Ramificação de prova: baixa !' D-dímero; intermediária/alta !' imagem sem atrasar anticoagulação se alto risco.



Conduta terapêutica

- Anticoagulação: heparina (HNF/HBPM) ou DOAC conforme cenário e estabilidade
- Trombólise: choque/PCR por TEP sem contraindicação absoluta
- TVP concomitante: USG de MMII ajuda se angioTC indisponível e alta suspeita
- Filtro de VCI: raro — falha/contraindicação formal à anticoagulação

Exames por cenário

Ferramenta | Papel

D-dímero | Excluir em baixa probabilidade

AngioTC pulmonar | Método de escolha na maioria

Ecocardiograma | VD / choque — à beira do leito

Gasometria / ECG | Apoio; S1Q3T3 é pouco sensível

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

D-dímero positivo não confirma TEP — só afasta quando negativo em baixa probabilidade. Em alta probabilidade, não 'espere o dímero': vá direto à imagem e trate o risco.